Psychologie du développement

Support non officiel

32 diapositives distinctes, classées dans l'ordre pédagogique du cours. Une capture par page, sans étirement de l'image. Les originaux sont conservés.

PARCOURS DU COURS

Fondements Captures 01 à 03 • page 2

Période anténatale Captures 04 à 06 • page 5

Petite enfance Captures 07 à 11 • page 8

Attachement Captures 12 à 17 • page 13

Enfant de 2-3 à 12 ans Captures 18 à 22 • page 19

Adolescence Captures 23 à 28 • page 24

Vieillissement Captures 29 à 32 • page 30

REPÈRES ET LIMITES

Tri de 110 captures : 32 retenues, 71 variantes redondantes écartées, 7 vues hors de cette sélection (bureau, explorateur et début de psychométrie).

Les captures du langage du bébé et des premières interactions manquent entre les captures 11 et 12. Consulter les sections 9 et 10 de la fiche reconstituée.

Les captures 4, 7, 16 et 17 ont du texte manquant aux bords. D'autres ont leur bandeau supérieur coupé. Ces limites sont indiquées sur les pages concernées.

La résolution reste celle des captures fournies. Le texte original est reproduit tel quel : cette compilation ne constitue ni un support officiel ni une validation des formulations. Les précisions et rectifications figurent dans la fiche reconstituée.

Psychologie du développement et psychologie de l'enfant

Pour rappel

On parle de psychologie de l'enfant et de psychologie du développement, sans que leurs champs respectifs ne se recouvrent complètement. On distingue donc :

1. **La psychologie du développement** comme étude de la genèse des conduites et des systèmes qui la structurent, s'appliquant à l'ensemble de l'existence (et donc fonction de l'âge)
2. **La psychologie de l'enfant** qui recueille des informations sur les compétences et les performances psychologiques des enfants et aboutit à des conclusions appliquées relatives à l'élevage et à l'éducation.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Inné et acquis

Introduction : l'inné et l'acquis, le normal et le pathologique (1)

L'inné et l'acquis

1. Un débat philosophique ancien
2. Remise en cause par l'évolutionnisme (Lamarck, Darwin) et la naissance de la génétique
3. Distinction génotype/phénotype, lois de Mendel (ségrégation, indépendance des caractères, dominance), découverte des chromosomes et des gènes (Morgan) puis de l'ADN
4. Interaction entre gènes et environnement : notion d'épigenèse
    1) neurobiologique
    2) psychologique

→ le programme neurobiologique précâblé ne suffit pas, les stimulations de l'environnement sont fondamentales.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Normal et pathologique

Le normal et le pathologique

• Le normal

Plusieurs définitions :

1) Statistique
2) Norme sociale
3) Comme idéal
4) Comme absence de maladie (cf. concepts de prévalence, incidence des maladies).

• Le pathologique

Concerne un état de maladie caractérisée par son étiologie et sa pathogénie, plusieurs définitions :

1) Statistique (rareté etc.)
2) Professionnelle (est pathologique ce qui est désigné comme tel par le médecin, le psy etc.)
3) Sociale (anormalité, concept relatif à la culture)
4) Existentialiste (modification de l'environnement plutôt que de l'individu)
5) Pratique (relatif à trois critères : inconfort, bizarrerie, inefficacité)

Conclusion : Problème de la continuité ou de la discontinuité du normal et du pathologique

Capture source : Bandeau supérieur déjà tronqué dans la capture ; contenu central conservé.

Le devenir parent

Le devenir parent

Il faut distinguer :

- **Désir de grossesse** : désir d'éprouver le sentiment d'être pleine (sentiment de complétude), d'obtenir quelque chose du partenaire, il peut aussi apparaître comme le désir de la femme de vérifier son bon fonctionnement biologique, de prouver à soi comme aux autres, qu'on est en capacité de procréer sans pour autant être prêt à accorder au bébé le statut de sujet désirant, à le recevoir dans son altérité.
- **Projet d'enfant** : il se présente souvent comme une démarche consciente, raisonnable, voire programmée, s'intégrant dans un plan de vie lié aux idéaux sociaux, culturels et familiaux, il a à voir avec l'intégration de l'enfant dans la sphère conjugal, quand il s'agit d'un projet de couple, d'un passage de deux à trois. Avec les PMA et le contrôle conceptionnel, les futurs parents peuvent avoir l'illusion d'"une toute-puissance où le projet de bébé semble animé par une volonté de maîtrise illusoire. A l'opposé, l'expression « tomber enceinte » dit bien l'imprévisible, le fait que tout projet d'enfant est hypothétique, aléatoire.
- **Désir d'enfant** : il a des composantes diverses conscientes et inconscientes.

Corrélativement, il faut à partir de là distinguer :

- **L'enfant réel**
- **L'enfant imaginaire** :

Pour Soulé, l'enfant imaginaire est le fruit du désir œdipien, il est investi d'un projet narcissique considérable «c'est un enfant comme sa propre mère aurait rêvé d'en avoir un, mais elle ne l'a pas été», on peut parler de réactivation du narcissisme infantile parental (ses ambitions, ses espoirs d'où les projections parentales).

Le **deuil de l'enfant imaginaire** supposera qu'à la naissance du bébé, la mère et le père puissent rencontrer le bébé de la réalité, l'adopter avec ses caractéristiques propres qui sont souvent différentes de celles qui avaient été imaginées et lui prodiguent des soins avec plaisir. Toute naissance amène un enfant et ses parents à s'adopter mutuellement mais si la distance entre enfant réel et imaginaire est trop grande, ce travail d'adoption mutuelle peut être laborieux voire

Capture source : Bords supérieur et inférieur déjà coupés dans la capture.

Itinéraire psychique de la maternité et de la paternité

Itinéraire psychique de la maternité et de la paternité

Les débuts de la grossesse

Au début, la future mère ne ressent pas encore les caractéristiques somatiques de la grossesse. La future mère est centrée sur elle-même, sur la perception des changements de son corps (seins etc.) ou de ses goûts. Ses fantasmes sont plutôt tournés vers elle, accompagnés d'affects variés et parfois contradictoires : fierté mais aussi anxiété, souvent en rapport avec les bouleversements de l'image du corps et les fantasmes d'étrangeté s'y rapportant. Soulé décrit cette période comme un « blanc d'enfant ». C'est la période du « je suis enceinte » et pas encore du « j'attends un enfant ». La première échographie vient en général faire irruption dans ce qui n'était auparavant ressenti que par des changements somatiques minimes et sans rapport direct avec une preuve de la présence du fœtus.

Le second trimestre

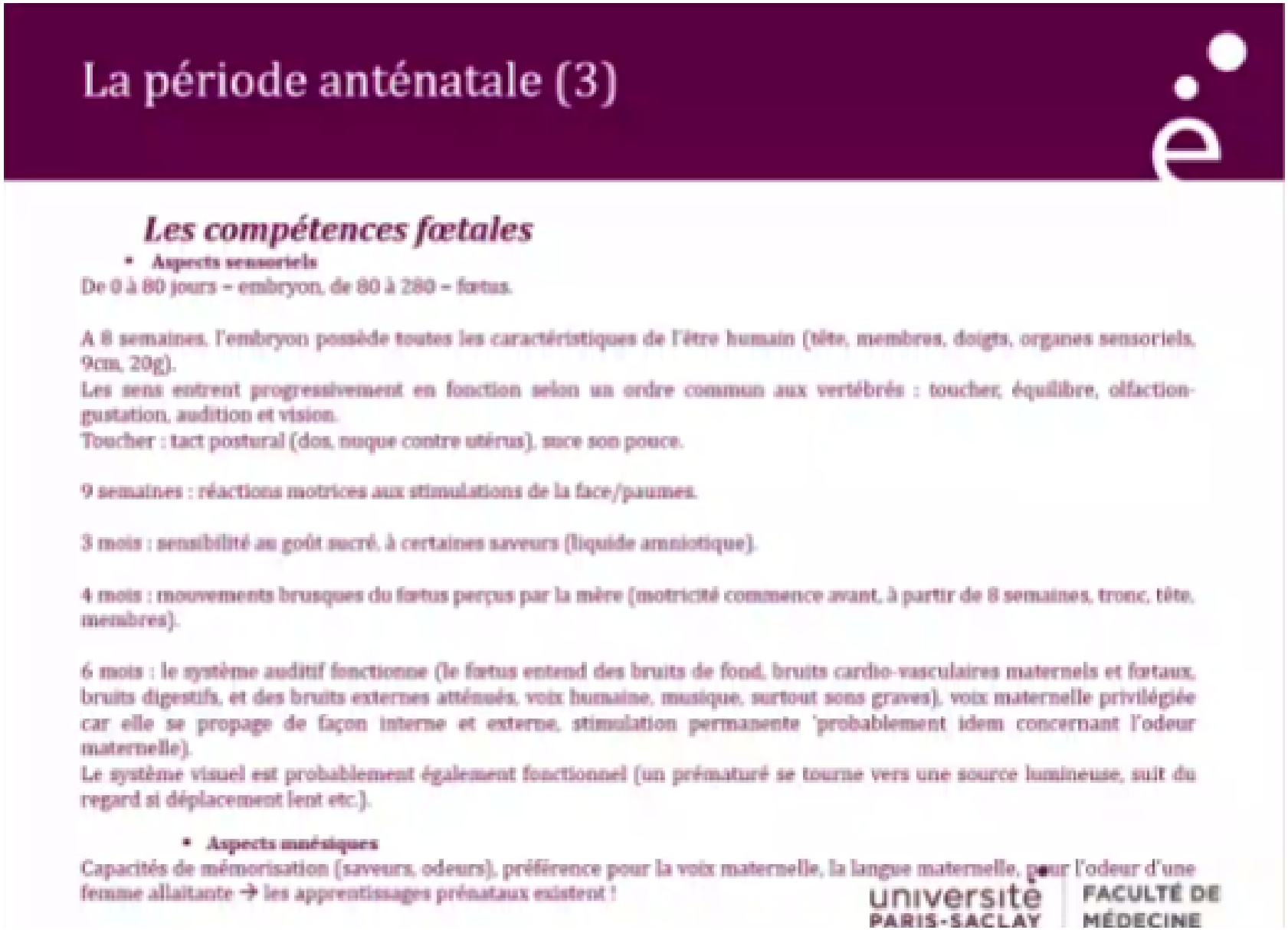
Caractérisé par la perception des premiers mouvements du bébé qui contribuent à donner à la mère des preuves tangibles de la présence de l'enfant et de sa croissance, autant d'indices sécurisants lui permettant de s'autoriser inconsciemment à investir progressivement cet enfant sans risque pour son propre psychisme : il est là, il est bien vivant et il grandit et prend de plus en plus de place. Les représentations de l'enfant s'élaborent et s'enrichissent progressivement. Le second semestre est souvent le plus confortable, dans tous les sens du terme car la future mère peut laisser libre cours à ses fantaisies, est rassurée sur le bon déroulement de la grossesse, habituée à son nouvel état, pas encore trop gênée par le volume du bébé et relativement moins de l'échéance de la naissance en tant que séparation.

Le troisième trimestre

Ces représentations cèdent petit à petit face à l'appréhension et l'excitation de l'accouchement, la future mère (et le père !) se prépare à la rencontre avec le bébé réel, à présent viable. Peuvent alors survenir des épisodes à caractère un peu dépressif ou des (petites) alertes somatiques, témoins parfois de l'anxiété de la jeune mère, et aussi de son ambivalence normale vis-à-vis du bébé. Evidemment, c'est un itinéraire singulier...

Capture source : Bandeau supérieur déjà tronqué dans la capture ; contenu central conservé.

Les compétences fœtales



Capture source : Le bas du logo est coupé dans la source ; les paragraphes restent visibles.

Développement postural et moteur : nouveau-né et nourrisson

Développement postural et moteur

- **Le nouveau-né (de 0 à 3 semaines)**

Néoténie, après le cri de la naissance, quelques minutes d'éveil, d'attention visuelle (importance pour l'attachement), puis position fœtale (hypertonique), somnolence, mouvements globaux. Il peut téter, déglutir, expulser le méconium, éveil 7 à 8 fois par jour pour téter. Réflexes archaïques : Moro, marche automatique, réflexe d'agrippement, disparaissent au cours des premiers mois.

- **Le nourrisson (de 3 semaines à 12- 15 mois)**

Le bébé suit les objets des yeux puis de la tête (intérêt pour les visages ++), contrôle progressif des différents segments du corps : muscles cou puis visage, torse, membres (épaules, bras mains), idem pour membres inférieurs. Au départ réactions globales à la stimulation (gesticulation) puis plus localisées.

- **Préhension**

4 mois : coordination visuo-manuelle
5 mois : préhension avec paume + 3 derniers doigts
6-7 mois : doigts en râteau + paume
9 mois : préhension entre le pouce et l'index (schème de la pince).

- **Station assise**

2-3 mois : tenue de la tête dans le prolongement du tronc
4-5 mois : soulève la tête, les épaules
6 mois : dos droit
7-8 mois : étend jambes pour une meilleure assise
9 mois : s'assoit.

- **Station debout puis marche**

6-8 mois : se renverse dos→ ventre
8-10 mois : ventre → dos
9 mois : debout avec un appui main

Capture source : Capture partielle : le haut et la fin de la rubrique marche sont absents.

Développement postural et moteur : de 1 à 3 ans

Développement postural et moteur

- **L'enfant (de 1 à 3 ans)**

18 mois et plus : marche assurée, monte les escaliers en donnant la main.

2 ans : court, monte les escaliers seul, lance une balle, commence à s'habiller seul, contrôle sphinctérien (pas possible avant l'acquisition de la marche → maturité neuromotrice) diurne, oublis encore fréquents, motricité fine : gribouillage, enfile des perles, tourne les pages d'un livre, construit une tour avec des cubes.

3 ans : propreté nocturne, court tout droit, saute à pieds joints, descend les escaliers un pied après l'autre, tricycle, bonne coordination main/doigts, trace des cercles, dessine une forme qu'il/elle dénomme.

Capture source : Bandeau supérieur déjà tronqué dans la capture ; contenu central conservé.

Capacités perceptives et cognitives du bébé

Perception et intelligence

- **Les capacités perceptives et cognitives des bébés**

1) La discrimination (quelques semaines : discrimine voix, photo de la mère ; 5-6 mois : visages, timbres de voix exprimant diverses émotions)
2) La catégorisation (4 mois : catégorisation d'images : 7 mois : images selon le sexe)
3) Coordination des modalités sensorielles (ex : anticipation d'une collision)
4) Permanence de l'objet (8 semaines : anticipation du regard la sortie d'un objet derrière un écran → trajectoire plus que forme cf. sous-stade IV : erreur A non B et sous-stade VI : reconstitution mentale de la trajectoire de l'objet)
5) Connaissances sur la physique des objets (surprise devant des événements impossibles → gravité, trajectoire, matière).

Capture source : Bandeau supérieur déjà tronqué dans la capture ; contenu central conservé.

Piaget : définition des principaux concepts

Perception et intelligence

- **L'intelligence sensori-motrice de J. Piaget**

Définition des principaux concepts

1) Schème (actions fondamentales de la connaissance, soit physiques telles vision, succion, préhension etc., soit mentales telles classement, comparaison etc.)

2) Adaptation (ensemble des modifications des conduites permettant un équilibre des relations entre l'organisme et son milieu)

3) Assimilation (une expérience nouvelle est assimilée à un schème → intégration de nouvelles données à des conduites antérieures)

4) Accommodation (un schème est créé ou modifié par accommodation => transformation d'un schème de conduite antérieur pour le rendre compatible avec le traitement de nouvelles données)

5) Equilibration (restructuration périodique des schèmes permettant à l'enfant de maintenir une cohérence dans sa compréhension du monde, il y a 3 équilibrations : l'intelligence sensorimotrice jusqu'à 2 ans, l'intelligence opératoire concrète à partir de 6 ans et l'intelligence formelle à partir de l'adolescence)

Capture source : Bandeau supérieur déjà tronqué dans la capture ; contenu central conservé.

Piaget : succession des sous-stades sensori-moteurs

Perception et intelligence

- **L'intelligence sensori-motrice de J. Piaget**

Succession des sous-stades

1) Sous-stade I (1er mois) : exercices des réflexes qui deviennent des activités (avec un sens et une recherche), début de l'assimilation et de l'accommodation).

2) Sous-stade II (2 à 4 mois) : réactions circulaires primaires (reproduction active d'une action fortuite concernant le corps propre et ayant produit un résultat intéressant, par ex. : la vocalisation).

3) Sous-stade III (4 à 8-9 mois) : coordination vision-préhension et réactions circulaires secondaires orientée vers les objets, début de l'intentionnalité (ex : agiter un objet sonore), activité exploratoire, début de la coordination moyen-but.

4) Sous-stade IV (9 à 11-12 mois) : coordination des schèmes secondaires et application à des situations nouvelles, développement des liens de causalité, distinction moyen-but, anticipation, utilisation d'un objet pour en déplacer un autre (par ex. main de l'adulte pour actionner un hochet).

5) Sous-stade V (12 à 18 mois) : réactions circulaires tertiaires (expérimentations avec variation des paramètres : gravité, enfant qui enfonce dans l'eau un jouet pour voir si ça remonte etc.), conduite du support/de la ficelle/ du bâton pour approcher un objet éloigné.

6) Sous-stade VI (18 à 24 mois) : invention de moyens nouveaux par combinaison mentale, apparition de représentations mentales (cf. imitation différée, présente avant 18 mois selon certains), insight (combinaisons mentales de schèmes intériorisés), constructions des schèmes de l'objet permanent, de l'espace (cf. la marche), du temps (en lien avec les déplacements d'où avant/après), de la causalité.

Capture source : Bandeau supérieur déjà tronqué. Les captures sur le langage et les premières interactions manquent ensuite.

Attachement : définitions, carences et séparations

La petite enfance de 0 à 2 ans (8) : Les apports de la théorie de l'attachement

Définition

Dérivé du verbe estachier (attacher en ancien français), le mot attachement apparaît en 1231 et se définit comme un engagement, sentiment qui lie, unit fortement à quelqu'un, puis comme application, attention et enfin comme attache, ce qui sert à attacher.

La théorie de l'attachement est élaborée dans les années 50 par un psychanalyste anglais, J. Bowlby, et diffusée en France dans les années 70. Elle a récemment pris un essor considérable et se fonde sur une nouvelle compréhension de la genèse du lien fondamental entre le bébé et ceux qui l'élèvent, en supposant un besoin inné de proximité chez le bébé avec les figures censées le protéger, proximité lui procurant un sentiment de sécurité fondamental pour son développement émotionnel, social et cognitif.



Les origines historiques

La théorie de l'attachement est née de 2 types de recherches : celles portant sur les carences affectives (juste après-guerre) et les travaux issus de l'éthologie.

La guerre et ses effets

Après la seconde guerre mondiale se pose la question des répercussions de la perte, la séparation, le deuil, l'abandon sur le développement du jeune enfant (en lien avec les expériences traumatisantes provoquées par les guerres, les génocides etc.).

a) Spitz et les carences affectives

De careo (être exempt de, manquer, d'où l'idée du manque, du besoin), la carence affective est conçue sur le modèle de la carence alimentaire (il faut une nourriture affective au psychisme pour son bon développement, quand elle manque il y a carence). Les observations de René Spitz (psychanalyste d'origine austro-hongroise, connu pour sa théorisation des trois organisateurs, le sourire, l'angoisse du huitième mois et le non) sont pionnières : en 1946, il observe 123 nourrissons abandonnés ou placés, âgés de 12 à 18 mois dans une pouponnière destinée aux enfants de mères emprisonnées et découvre chez eux la présence de symptômes dépressifs.

b) Les travaux de Robertson

Travailleur social engagé par Bowlby pour faire des travaux d'observation sur les effets de la séparation en milieu hospitalier, il décrit 3 phases évolutives de la séparation durable chez le jeune enfant (les films des Robertson sur deux enfants, accueillis en crèche, ont été un choc pour les professionnels de l'enfance).

Phases de la séparation :

1) la protestation : l'enfant est effrayé, crie, pleure, réponse active à la séparation, l'enfant lutte pour rétablir la proximité à l'aide de comportements-signaux innés comme les pleurs,

2) le désespoir : phase de réaction passive, les comportements-signaux ont été mis en échec, l'enfant perd tout intérêt pour son environnement, apparition de signes végétatifs, refus de s'alimenter etc.

3) le détachement : l'enfant réprime les comportements visant à établir la proximité du parent, il peut reprendre un peu de vitalité mais au prix d'une indifférence affective, ayant comme abandonné l'idée d'obtenir du réconfort des autres.

La dépression anaclitique

Dans la description princeps de Spitz, la dépression anaclitique a été décrite chez des nourrissons séparés de leur mère alors qu'ils sont âgés de six et huit mois (et que pendant leurs premiers mois de vie, c'est leur mère qui a eu le soin exclusif de ces nourrissons) et les symptômes sont décrits comme cédant rapidement au retour de la mère ou s'il est possible de créer une relation privilégiée avec un substitut. Les symptômes consistent dans un premier temps à des pleurs et des cris, puis suit une attitude de repli, avec fuite du contact, et des troubles psychosomatiques (troubles du sommeil, de l'alimentation avec perte de poids, grande sensibilité aux troubles infectieux), une baisse du quotient de développement voire une régression en ce qui concerne les apprentissages (moteurs entre autres), et enfin succède un état de rigidité glacée, d'hébétude avec anorexie et activités auto-érotiques de tous ordres.

L'hospitalisme

L'hospitalisme a été décrit dans des conditions un peu différentes : les bébés étaient âgés de trois à six mois, la perte de l'objet maternel était définitive et il n'y avait pas de possibilité de proposer un substitut maternel de qualité (l'hospitalisme a donc d'emblée à voir avec des carences graves redoublées par une prise en charge institutionnelle défaillante : il est décrit par Spitz dans un home d'enfants où une nurse s'occupe de dix bébés). Un tableau de stupeur catatonique s'installe avec une répugnance à toucher les objets (et une impossibilité de les lâcher quand ils ont été saisis), et des jeux inhabituels avec les doigts et les mains (qui évoquent clairement les stéréotypies autistiques, comme se passer les mains devant les yeux etc.).

NB : Si rien n'est fait pour traiter la dépression anaclitique (qui n'est pas spontanément résolutive), le pronostic rejoint celui de l'hospitalisme (à savoir un état de marasme de plus en plus inquiétant, tant sur le plan physique que psychique).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Attachement : éthologie, psychanalyse et Bowlby

La petite enfance de 0 à 2 ans (9) : Les apports de la théorie de l'attachement

Les découvertes de l'éthologie (Lorenz, Harlow)

La théorie de l'attachement est fortement marquée par les apports de l'éthologie (et au-delà par le darwinisme et la théorie de l'évolution) : il y aurait un avantage adaptatif de l'attachement et une continuité de ces comportements (l'attachement n'est pas un phénomène exclusivement humain cf. comportements de maternage communs aux mammifères, il faut cependant être prudent avec les inférences tirées des études sur les animaux et appliquées aux humains).

Ethologie : étude du comportement animal tel qu'il peut être observé chez l'animal sauvage ou l'animal domestique en milieu naturel ou en captivité.

Le concept d'**empreinte** est le mécanisme par lequel les bébés animaux se mettent à suivre tout objet mobile présent au moment de leur naissance ou dans les minutes qui suivent (la réaction de poursuite est réflexe mais l'objet est acquis par l'expérience, cf. les travaux de K. Lorenz sur les oies, les films « l'envolée sauvage », « le peuple migrateur » etc.).

L'idée d'un **besoin primaire de contact physique** (tactile, thermique), source de réconfort, émerge des travaux de Harlow sur les singes rhésus (isolés et séparés de leur mère à la naissance, ils préfèrent un substitut maternel doux en chiffons plutôt qu'un substitut dur en grillage, qu'il fournisse de la nourriture ou pas).

NB : la présence ou non d'un substitut a des effets sur les comportements d'exploration des jeunes (balance proximité/exploration).





Les apports de la psychanalyse (Freud, Anna Freud, Winnicott)

Freud montre dans ses travaux un intérêt pour les relations précoces, le développement, la question de l'angoisse en lien avec la peur de la séparation et de la perte d'objet. Anna Freud reconnaît le poids de la séparation dans la clinique de la petite enfance (à l'occasion du Blitz notamment), adopte une perspective développementale et parle d'un besoin primaire d'attachement. Winnicott développe certains concepts proches de la théorie de l'attachement :

- La **préoccupation maternelle primaire** : état psychique particulier de la mère qui prend naissance pendant la grossesse et qui se prolonge après la naissance, sorte de folie maternelle caractérisée par une adaptation et une hypersensibilité aux états internes et signaux de son bébé (tout ce qu'il lui communique),
- L'importance de la qualité des soins premiers (corporels et psychiques) prodigués au bébé pour son développement : le **holding** désigne le portage, la manière dont le bébé est porté (contenance, ce qui permet au bébé de se sentir unifié, en sécurité, dans un environnement prêt à le soutenir, le contenir) ; le **handling** désigne la maintenance, la manière dont l'enfant est manipulé (rythme des soins en adéquation ou non avec ceux du bébé, adaptation tonico-posturale au bébé etc.), ayant une fonction personnalisante, le bébé se sent accueilli comme une personne ; l'**object-presenting** ou présentation d'objet, manière dont l'entourage introduit dans la relation au nouveau-né différents objets du monde extérieur, animés ou non, permettant une ouverture sur le monde.



Bowlby, le fondateur

Né en 1907, médecin, psychanalyste à partir de 1937, intéressé très tôt par les liens entre troubles du comportement et histoire infantile, admirateur et lecteur de Darwin. En 1944, il publie son étude « 44 jeunes voleurs, leur personnalité et leur vie de famille ». Psychiatre militaire pendant la guerre, en 1946 il travaille à la Tavistock Clinic à développer un service de psychiatrie de l'enfant. En 1951, l'OMS lui demande un rapport sur les enfants sans famille : il insiste sur l'effet de la carence de soins maternels (donnant relations affectives superficielles, troubles de la concentration, inaccessibilité à l'autre, absence de réaction émotionnelle, vol sans but etc.) => impact énorme et polémique (féministes, personnels hospitaliers, psychanalystes etc.). De 1953 à 1956, il participe à un séminaire sur l'approche éthologique de la recherche sur le développement de l'enfant, il y travaille avec Lorenz, Piaget, Zazzo, M. Mead (anthropologue), Bertalanffly (théoricien des systèmes et de l'information) et rencontre Harlow en 1958.

La théorie de l'attachement naît de ce melting-pot (éthologie, psychanalyse, cybernétique, théorie des systèmes, psychologie cognitive et du développement etc.).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Attachement : principaux concepts et émotions

La petite enfance de 0 à 2 ans (10) : Les apports de la théorie de l'attachement

Les principaux concepts

- L'attachement, un besoin primaire

L'attachement constituerait un besoin social primaire => tendance originelle et permanente à rechercher la relation avec autrui, l'attachement une fois formé ayant pour nature de durer. Sa fonction à l'échelle de l'espèce est vraisemblablement double : de protection à l'égard des prédateurs et de survie.

- Les comportements d'attachement

Comportements du bébé destinés à favoriser la proximité avec l'objet d'attachement :
- sourire/vocalisations (comportements-signaux qui indiquent que l'enfant cherche l'interaction),
- cris/pleurs (comportements aversifs, ayant pour but de rapprocher l'objet d'attachement pour qu'il y mette fin),
- agrippement (s'accrocher)/poursuite, à 4 pattes, en marchant, (comportements actifs de l'enfant qui permettent de se rapprocher).

Comportements semblant de nature innée, ils favorisent l'attachement réciproque entre enfant et adulte. Au fur et à mesure du développement, d'autres comportements (acquis) vont être utilisés dans le même but et devenir des comportements d'attachement (c'est-à-dire organisés dans l'objectif de favoriser la proximité de quelques figures préférentielles).

- Figure d'attachement

Figure vers laquelle l'enfant dirige son comportement d'attachement, donc toute personne s'engageant dans une interaction sociale durable et animée avec le bébé, répondant facilement à ses signaux et ses approches.

- Caregiver et caregiving

Cette réponse aux besoins d'attachement de l'enfant peut s'organiser en système réciproque (ou complémentaire) du système d'attachement de l'enfant : il s'agit du caregiving (fonction de prendre soin, souvent dévolue aux parents mais pas uniquement). Le caregiver cherche à rétablir ou maintenir la proximité physique et psychologique avec le bébé quand il est en situation de danger ou de détresse afin de répondre à ses besoins et de le protéger. Le caregiving est associé chez le caregiver à des émotions spécifiques : plaisir/satisfaction/soulagement quand il peut protéger l'enfant, colère/tristesse/anxiété quand il ne le peut pas.

- Recherche de proximité et base de sécurité

Proximité : notion spatiale, distance entre l'enfant et la figure d'attachement qui peut être modulée en fonction des besoins de l'enfant, le système d'attachement se définit comme ce qui maintient la proximité et de manière interne, le sentiment de sécurité (d'où l'idée de base de sécurité, renvoyant à la confiance dans l'idée qu'une figure protectrice sera accessible/disponible, quel que soit l'âge de l'individu, l'existence d'une base de sécurité permettant à l'enfant d'explorer le monde qui l'entoure).

L'émotion

Définition

De movere (latin : mouvoir) et e (hors de) : «Mouvement hors de soi»
Réaction survenant le plus souvent brusquement et pour une durée relativement brève à l'apparition d'une situation significative pour le sujet. Réaction qui est à la fois cognitive (processus cognitifs) et à la fois biologique.

Les 6 émotions de base/ primaires (Paul Ekman)

- La joie
- La colère
- La tristesse
- La peur
- Le dégout
- La surprise

Le rôle des émotions dans l'attachement

Les émotions ont un rôle de motivation, d'autocontrôle, de communication dans le contexte de la relation d'attachement :
- Angoisse : active le système d'attachement et conduit à l'apparition de comportements d'attachement pour rétablir la proximité, signal de communication pour la détresse.
- Peur : centrale, traduit le vécu de menace par rapport à la survie du bébé, active le système d'attachement.
- Colère : réponse à la rupture du lien d'attachement (pour Bowlby, lors d'une séparation temporaire, la colère peut servir à motiver l'enfant pour surmonter les obstacles à la réunion avec la figure d'attachement, et sert à lui reprocher son éloignement, à la décourager de recommencer).
- Tristesse : provoquée par la prise de conscience que la figure d'attachement est indisponible quels que soient les efforts faits pour rétablir son accessibilité, elle peut conduire au retrait, au désengagement.
- Emotions positives (joie etc.) : apporte un sentiment de sécurité (détente, bien-être, confort liés à la proximité de la figure d'attachement).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Attachement : construction dans la petite enfance

La petite enfance de 0 à 2 ans (11) : Les apports de la théorie de l'attachement

L'attachement dans l'enfance

a) De 0 à 3 mois

L'orientation et les signaux sans discrimination d'une figure : les comportements d'attachement présents dès la naissance ne sont pas dirigés vers une figure spécifique mais vers les adultes qui approchent le bébé.

b) De 3 à 6 mois

L'orientation et les signaux dirigés vers une ou plusieurs figures individualisées : début de différenciation étranger/familier, orientation active des comportements (pleurs, cris etc.) vers les figures familières en cas de détresse de façon à rapprocher l'adulte. Sourires et babillages s'adressent plutôt à la figure d'attachement principale, ainsi que l'orientation visuo-posturale (entre 16 et 18 semaines). Début d'apparition des **Modèles Internes Opérants (MIO) sensori-moteurs (modèles mentaux de soi, autrui et des interactions qui aident à comprendre et interpréter les comportements des proches, les réactions d'autrui)**.

c) De 6 mois à la troisième année

Le maintien de la proximité avec une figure discriminée par les signaux et la locomotion : le contrôle de la motricité permet à l'enfant de gérer la proximité, rôle actif dans la gestion de la distance optimale avec la figure d'attachement. Début de la base de sécurité et peur de l'étranger (angoisse de séparation), de la communication verbale qui permet le développement de comportements corrigés quant au but (adaptation à ce que l'enfant comprend des attentes de l'autre). Proximité physique associée aux idées de disponibilité et d'accessibilité.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Attachement : situation étrange et organisations

petite enfance de 0 à 2 ans (12) : s apports de la théorie de l'attachement

es applications cliniques et thérapeutiques

rts de l'observation : la « strange situation » (M. Ainsworth)

worth, après des travaux d'observation d'interactions mère-enfant en milieu naturel, a imaginé une situation expérimentale, deven permettant de décrire la capacité d'un enfant à utiliser sa figure d'attachement comme base de sécurité. Mise au point pour des enfant ois observés avec leur figure d'attachement en laboratoire, on note les réactions de l'enfant durant 8 épisodes de séparation et retrou ant également l'introduction d'une personne non familière. 3 groupes d'enfants ont été différenciés selon leur comportement dur s de réunion avec la mère.

rois types d'attachement

Sécure

unts attachés de manière ***sécure*** ont tendance à protester lors des séparations, à accueillir la mère avec plaisir (sourire, vocalisation, ge erchant la proximité avec elle et à retourner jouer après avoir été réconfortés.
tachement sécure favorise l'estime de soi, la socialisation, l'adaptation scolaire, la régulation des émotions, les capacités exploratoires.

Insécure évitant

s enfants ont peu de manifestations affectives ou de comportements de base de sécurité, ils paraissent peu affectés par la séparation, te a proximité et le contact avec la figure d'attachement lors des retrouvailles, focalisent leur attention sur les jouets plutôt qu'elle lent pas de réconfort dans ce type de situations. S'ils sont stressés par la séparation, ils peuvent acceptés d'être réconfortés par l'étrang

Insécure ambivalent/résistant

trent de la détresse à la séparation avec un mélange de recherche de contact et de rejet coléreux de leur figure d'attachement, et des dif éconfortés.

uatrième type d'attachement : l'attachement désorganisé (M. Main)

risque développemental, les enfants avec attachement désorganisé montrent des comportements bizarres, inhabituels, contradicto uels au moment des retrouvailles lors de la strange situation (par ex. attachement intense *et* figement, évitement marqué du agné de détresse ou colère, mouvements ou expressions non dirigés, incomplets, interrompus etc.). Il y a incapacité de l'enfant à ma atégie cohérente et prévisible, comportementale et cognitive, face au stress en fonction des réactions habituelles du caregiver ('effrayant, du fait d'un traumatisme du passé irrésolu) → le parent est à la fois source d'alarme et de réconfort pour l'enfant.

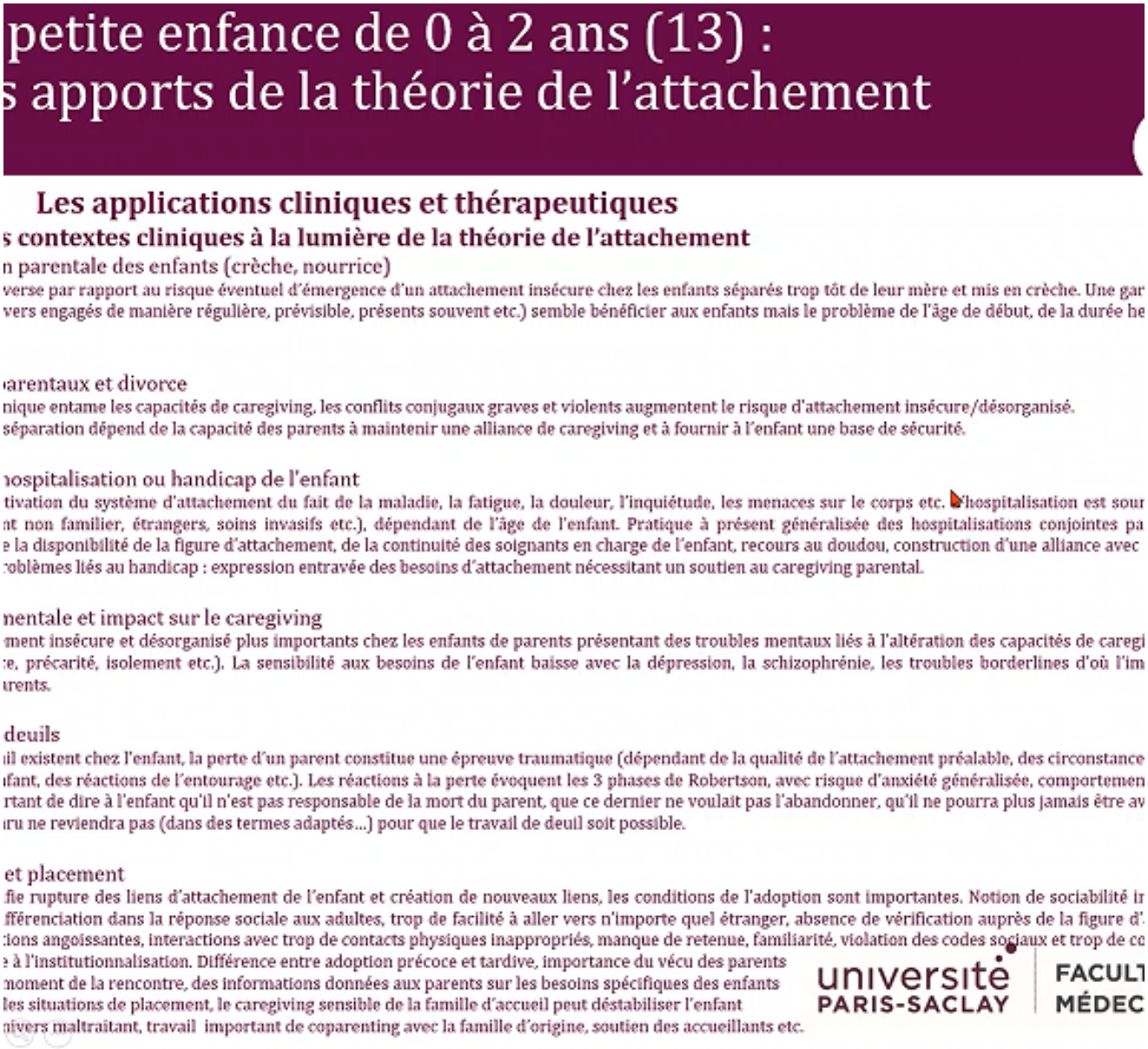
que et limites : les types d'attachement ?

n de l'influence de la culture, de la capacité prédictive de la strange situation etc.

université PARIS-SACLAY | FACULT MÉDEC

Capture source : Capture tronquée à gauche et à droite. Pour compléter la lecture : fiche reconstituée, section 15.

Attachement : applications cliniques et thérapeutiques


petite enfance de 0 à 2 ans (13) :
s apports de la théorie de l'attachement

Les applications cliniques et thérapeutiques

s contextes cliniques à la lumière de la théorie de l'attachement

n parentale des enfants (crèche, nourrice)

verse par rapport au risque éventuel d'émergence d'un attachement insécure chez les enfants séparés trop tôt de leur mère et mis en crèche. Une gar
vers engagés de manière régulière, prévisible, présents souvent etc.) semble bénéficier aux enfants mais le problème de l'âge de début, de la durée he

arentaux et divorce

nique entame les capacités de caregiving, les conflits conjugaux graves et violents augmentent le risque d'attachement insécure/désorganisé.
séparation dépend de la capacité des parents à maintenir une alliance de caregiving et à fournir à l'enfant une base de sécurité.

ospitalisation ou handicap de l'enfant

tivation du système d'attachement du fait de la maladie, la fatigue, la douleur, l'inquiétude, les menaces sur le corps etc. L'hospitalisation est sour
nt non familier, étrangers, soins invasifs etc.), dépendant de l'âge de l'enfant. Pratique à présent généralisée des hospitalisations conjointes pa
e la disponibilité de la figure d'attachement, de la continuité des soignants en charge de l'enfant, recours au doudou, construction d'une alliance avec
roblèmes liés au handicap : expression entravée des besoins d'attachement nécessitant un soutien au caregiving parental.

nentale et impact sur le caregiving

ment insécure et désorganisé plus importants chez les enfants de parents présentant des troubles mentaux liés à l'altération des capacités de caregi
e, précarité, isolement etc.). La sensibilité aux besoins de l'enfant baisse avec la dépression, la schizophrénie, les troubles borderlines d'où l'im
rents.

deuils

il existent chez l'enfant, la perte d'un parent constitue une épreuve traumatique (dépendant de la qualité de l'attachement préalable, des circonstance
fant, des réactions de l'entourage etc.). Les réactions à la perte évoquent les 3 phases de Robertson, avec risque d'anxiété généralisée, comportemen
rtant de dire à l'enfant qu'il n'est pas responsable de la mort du parent, que ce dernier ne voulait pas l'abandonner, qu'il ne pourra plus jamais être av
ru ne reviendra pas (dans des termes adaptés...) pour que le travail de deuil soit possible.

et placement

fie rupture des liens d'attachement de l'enfant et création de nouveaux liens, les conditions de l'adoption sont importantes. Notion de sociabilité ir
fférenciation dans la réponse sociale aux adultes, trop de facilité à aller vers n'importe quel étranger, absence de vérification auprès de la figure d'
ions angoissantes, interactions avec trop de contacts physiques inappropriés, manque de retenue, familiarité, violation des codes sociaux et trop de co
à l'institutionnalisation. Différence entre adoption précoce et tardive, importance du vécu des parents
noment de la rencontre, des informations données aux parents sur les besoins spécifiques des enfants
les situations de placement, le caregiving sensible de la famille d'accueil peut déstabiliser l'enfant
nivers maltraitant, travail important de coparenting avec la famille d'origine, soutien des accueillants etc.

université PARIS-SACLAY | FACULT MÉDEC

Capture source : Capture tronquée à gauche et à droite. Pour compléter la lecture : fiche reconstituée, section 16.

Enfance : développement sémiotique

L'enfant d'âge scolaire de 2- 3 ans à 12 ans (1)

Le développement sémiotique

Utilisation de signes (langage, gestes symboliques, imitation différée, dessin, images mentales) pour évoquer objets/personnes/événements.

- **Développement du lexique**

Au début surtout des noms puis à partir de 400 mots, augmentation des mots de classe fermée, utilisation des mots en sous-extension (par ex. : chien pour caniche) ou en sur-extension (par ex. : chat pour tout animal à 4 pattes), développement de la syntaxe (phrase SVO, apparition de la 1ère personne vers 2 ans- 2 ans et demi), les capacités métasyntaxiques se développent à l'école (6- 7 ans), aspects pragmatiques du langage (expression de demandes avec des mots-phrases puis demandes de clarification (par ex. : quoi ?) entre 1 et 2 ans, demandes de précision (par ex. : où, pourquoi, quand ?) vers 3 ans, les demandes sont plus directes avec les familiers, les plus jeunes, les plus disponibles, les plus amicaux). Compréhension du langage non littéral plus tard (sarcasme vers 8 ans, expressions idiomatiques vers 10 ans) acquisition du langage écrit (double voie : orthographique et phonologique + question de la compréhension…).

- **Imitation différée et jeu symbolique**

Imitation en présence du modèle pendant la période sensori-motrice (par ex. : bravo !), puis après 2 ans imitation différée dans le temps (par ex. : imiter le trépignement d'un enfant en colère en riant), apparition du jeu symbolique = jeux de faire semblant, permet l'apprentissage des rôles sociaux et la maîtrise de situations désagréables.

- **Dessin**

A partir de 2 ans (avant : gribouillage), avec intention signifiante à 3 ans (avant : réalisme fortuit => interprétation après coup par l'enfant de sa production graphique), ex : bonhomme têtard, dessins en transparence (points de vue inconciliables, par ex. : dessin de l'intérieur du ventre de la maman enceinte), 8- 9 ans dessin plus réaliste (proportion, perspective).

- **Image mentale**

D'abord statique, puis cinétique vers 7- 8 ans, en lien avec le développement des opérations logico-mathématiques.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Enfance : intelligence préopératoire

L'enfant d'âge scolaire de 2- 3 ans à 12 ans (2)

Le développement intellectuel selon J. Piaget

- **Intelligence préopératoire concrète (de 2 à 7 ans)**

La représentation symbolique domine (cf. développement de la fonction sémiotique), Piaget entend par représentation l'action intériorisée. La pensée à ce stade est dominée par le symbolisme (cf. jeux symboliques, symbolisme personnel, non socialisé) et l'égocentrisme (incapacité à se détacher de son point de vue propre) avec :

1- Animisme (des choses puis des corps mobiles puis des corps doués de mouvements propres puis des êtres vivants)

2- Artificialisme (tout est fabriqué pour l'homme)

3- Réalisme (matérialisation de la pensée comme les rêves, interpréter les phénomènes mentaux comme concrets et physiques, c'est-à-dire comme des objets)

L'égocentrisme se manifeste aussi dans le langage comme un prisme déformant de la perception de l'enfant.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Enfance : intelligence opératoire concrète

L'enfant d'âge scolaire de 2- 3 ans à 12 ans (3)

Le développement intellectuel selon J. Piaget

- **Intelligence opératoire concrète (de 7 à 12 ans)**

Caractérisée par l'acquisition de la réversibilité logique autorisant une pensée plus mobile/ une décentration (annulation en pensée d'une transformation par inversion ou compensation). Les actions intériorisées réversibles sont des opérations (infralogiques : structuration de l'objet, connaissance de ses propriétés, logico-mathématiques : structuration du rapport entre les objets), chaque opération se caractérise par des propriétés invariantes :

❖ **Les opérations infralogiques**

Structuration de l'objet, connaissance de ses propriétés :

- ❑ Conservations physiques :
  - ➢ De la matière/substance solide et liquide (7- 8 ans)
  - ➢ Du poids (9- 10 ans)
  - ➢ Du volume (11- 12 ans)
- ❑ Conservations spatiales :
  - ➢ Des longueurs (7 ans)
  - ➢ Des surfaces (7 ans)
  - ➢ De l'horizontale/la verticale (8- 9 ans)
  - ➢ Des volumes spatiaux (11- 12 ans)
- ❑ Conservations numériques (7 ans)

❖ **Les opérations logico-mathématiques**

Structuration du rapport entre les objets :

- ❑ Classification (8 ans) :
  - ➢ relations d'inclusion, à 7- 8 ans les opérations de classification permettent de comparer la partie au tout (A + A'= B → B- A' =A). Ici, réversibilité par négation
- ❑ Sériation (7- 8 ans) :
  - ➢ relations d'ordre ; groupement d'objets par relation d'ordre , avec réversibilité par réciprocité E > D, C, B, A et E < F, G, H, I et transitivité si A > B et B > C alors A > C
- ❑ Nombre (8 ans- 8 ans et demi) :
  - ➢ suppose inclusion (classification : 1 ⊂ 2 ⊂ 3) et ordre (sériation : 1 < 1 + 1 < 1 + 1 + 1) ; importance de l'acquisition de la conservation numérique, au-delà,

utilisation des nombres relatifs, décimaux, fractions etc.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

NB : les troubles des apprentissages (la résignation apprise, troubles du langage oral, dyslexie/dysorthographie/dyscalculie).

Enfance : théorie de l'esprit

L'enfant d'âge scolaire de 2- 3 ans à 12 ans (4)

Le développement affectif et social

Rappel : Premiers signes de l'empathie chez les bébés (contagion affective des nouveaux nés), puis réactions plus élaborées de sympathie envers les pairs vers 2 ans, développement de l'attachement très marqué entre 6 mois et 2 ans, importance des échanges émotionnels (cf. travaux de Wallon sur l'expression émotionnelle, travaux de sur la dépression anaclitique et l'hospitalisme).

- **La théorie de l'esprit**

A partir de la 3ème année, l'enfant commence à comprendre comment influencer l'adulte par ses comportements → début d'une *théorie de l'esprit*, conçue comme la compréhension des états mentaux d'autrui.

❖ **Ses premiers précurseurs**

6 mois : réciprocité des jeux ritualisés, début de l'anticipation des comportements de l'adulte, à 8 mois demande à être pris en tendant les bras, à 1 an attention conjointe (suit le regard de la mère vers un objet et tend la main, geste interprété par l'adulte comme une demande) puis véritable geste de pointage, l'enfant initie les interactions. Avant 2 ans, l'enfant décode des expressions faciales → preuve d'une certaine compréhension des états mentaux d'autrui, entre 1 et 2 ans l'enfant oriente un objet pour que l'adulte le voit mais la moitié n'arrive pas à cacher à 2 ans et demi, à 3 ans cache-cache inefficace, pas de vrai jeu de cache-cache avant 4- 5 ans. Importance de la perception par rapport à la réalité immédiate.

❖ **Son développement**

Plusieurs études portent sur la compréhension des verbes mentaux (vouloir/savoir/croire), expériences à l'aide d'une poupée cherchant un objet caché (la compréhension des états mentaux d'autrui n'est pas acquise avant 7 ans) → attribution correcte de désirs/émotions/actions à autrui vers 2 ans et demi- 3 ans, de croyances à 3 ans, de fausses croyances vers 5- 6 ans, compréhension correcte des savoirs et des pensées, à 8 ans attribution correcte du verbe croire par la moitié des enfants, réussite totale seulement vers 11 ans, croyances du 2nd ordre (ce que quelqu'un pense à propos de la pensée d'un autre) vers 6-9 ans. Entre 5 et 8 ans, les enfants arrivent à se décentrer, à se mettre à la place d'un autre, à analyser causes et intentions, comprennent la réciprocité de la relation mais admettent difficilement que les mêmes conduites puissent avoir des causes différentes. Vers 12 ans, les actions d'une personne s'analysent en fonction des circonstances, de sa personnalité, de ses relations à autrui.

NB : Les enfants autistes auraient une théorie de l'esprit défaillante (problème d'attention conjointe, pas de pointage etc.).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Enfance : relations sociales et attachement

L'enfant d'âge scolaire de 2- 3 ans à 12 ans (5)

Le développement affectif et social

- **Les relations sociales**

Rôle de la socialisation (famille, pairs, médias permettent le développement des relations sociales etc.), influence du niveau socio-économique et socioculturel (par ex. : contact avec les livres stimule le développement du langage etc.).

Travaux sur les différents styles éducatifs (parents contractualisés / statutaires / maternalistes), sur les formes de cohésion familiale (famille bastion vs association), question des recompositions familiales, types des rapports sociaux intrafamiliaux (Piaget : 1. de contrainte → autorité unilatérale, hétéronomie et conformisme, 2. de coopération → égalité, respect mutuel des partenaires, réciprocité et autonomie).

La relation avec les pairs favorise la décentration (dès 2-3 ans, relations d'alternance et de réciprocité avec prise en compte du point de vue d'autrui), consensus, contrat, respect et loyauté (d'où l'évolution du leadership dans les groupes d'enfants : à 7-9 ans leaders forts et adroits, à 10 ans leaders équitables et solidaires).

Emergence des identifications sexuées (composantes biologiques, sociales, individuelles) :

- 2- 3 ans : les enfants se déclarent fille ou garçon et se fâchent si on se trompe
- 3- 4 ans : un garçon peut penser devenir maman, idem pour les filles
- 5- 6 ans : pensent qu'un changement d'apparence = changement de genre (ex : s'habiller en fille)
- 6- 7 ans : certitude du caractère définitif de l'appartenance sexuée…

- **Ce que dit la théorie de l'attachement**

a) De 2 ans et demi/3 ans à 4 ans
Phase de développement du lien d'attachement : développement des capacités cognitives et langagières provoquant des changements dans l'expression des comportements d'attachement, besoin de maintenir l'attention du caregiver sur l'enfant, langage et motricité permettent d'adopter la distance optimale par rapport à la figure d'attachement. La représentation mentale de la séparation aide à la tolérer (partenariat émergent : accord sur les modalités de séparation et retrouvailles).

b) De 4 ans à 12 ans
Le système d'attachement est moins au premier plan (les systèmes exploratoire et affiliatif prennent le relais), des figures auxiliaires d'attachement apparaissent, la sécurité de l'attachement devient caractéristique de l'enfant plus que de la relation spécifique à une personne.
A la fin de l'enfance, il a construit un **MIO de représentation des relations d'attachement** (plus ou moins cohérent en fonction des expériences).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Adolescence : corps et définition

L'adolescence (1)

La question du corps :

Phase de restructuration affective et intellectuelle de la personnalité en lien avec les transformations physiologiques liées à l'intégration du corps sexué (puberté) → grande variabilité interindividuelle du début de la puberté (10-17 ans), poussée de croissance vers 11-12 ans pour les filles, 2 ans plus tard pour les garçons, âge des premières règles entre 10 et 16 ans avec une moyenne à 13 (impact d'une puberté précoce ou tardive), apparition des caractères sexuels secondaires et maturation des caractères sexuels primaires (les organes reproducteurs du garçon et de la fille deviennent fonctionnels), fin incertaine (quel sens donner au statut d'adulte ? indépendance financière via insertion professionnelle ? création d'une nouvelle cellule familiale ? etc.).

Le corps est donc :

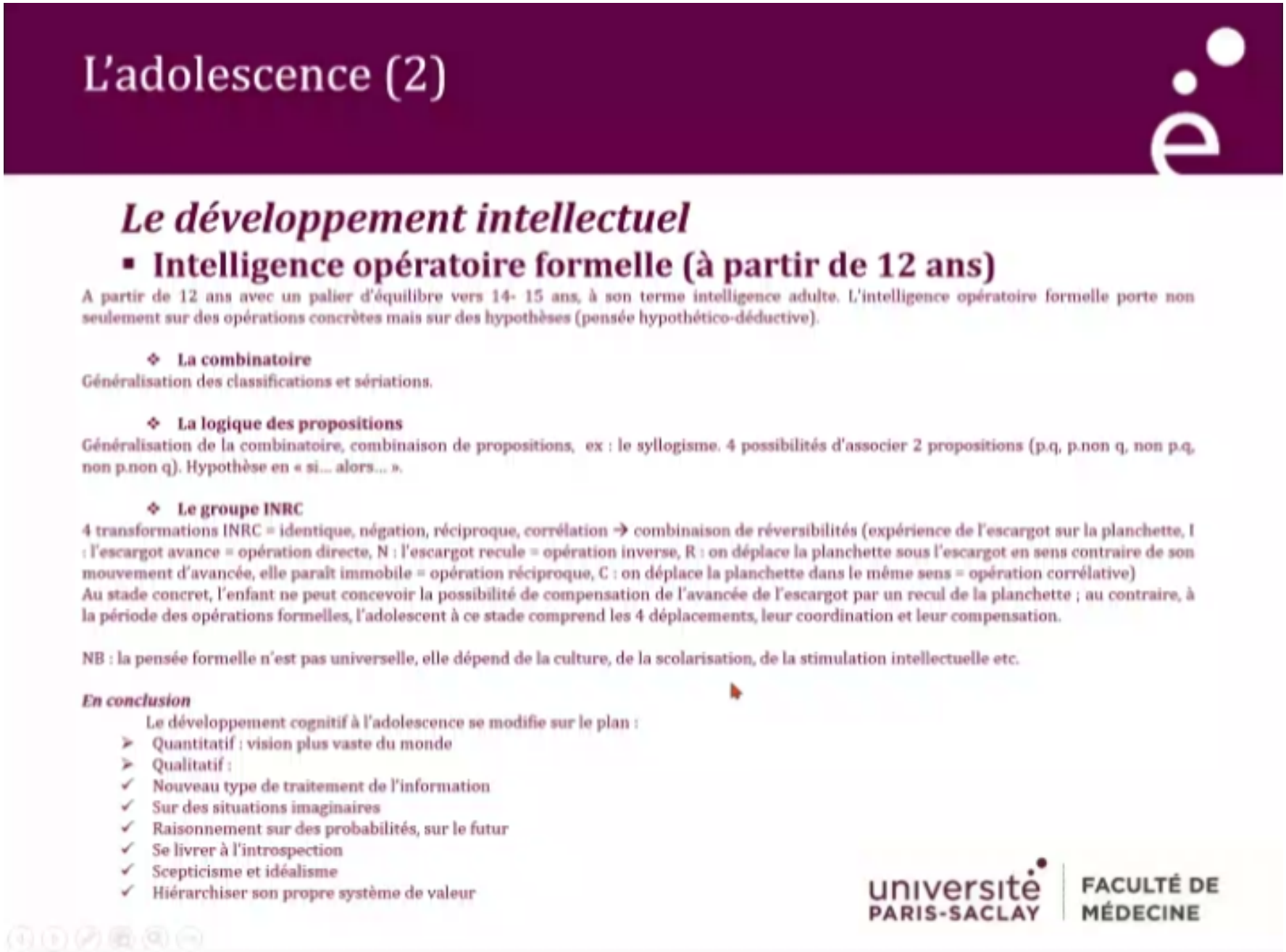
- Une préoccupation centrale
- En transformation
- Un moyen d'exprimer ses pulsions sexuelles et agressives

Tentative de définition :

- Evolution lente et profonde, ponctuée de ruptures brutales qui affectent aussi bien le corps que la personnalité et les comportements, la relation à soi et aux autres (A. Braconnier, D. Marcelli) → Intégrer les modifications de la puberté dans le schéma de la personnalité particulier à l'individu en question.
- Quelle est la pertinence de la notion de crise à l'adolescence ?
- L'adolescence comme âge de la vie est très tributaire d'aspects culturels (rites initiatiques avec séparation sociale dans certaines cultures dites traditionnelles, crise d'adolescence et adolescence interminable, manifestations violentes et/ou conflictuelles dans les cultures occidentales etc.).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Adolescence : développement intellectuel



Adolescence : langage, morale et idéologie

L'adolescence (3)

Le développement du langage

- **L'argumentation**

Rappel : à 3 ans, premiers arguments, à 4 ans, adaptation de l'argumentation à l'interlocuteur.
Argumentation élaborée suppose une théorie de l'esprit, articulation arguments/contre-arguments (concession, restriction, spécification), justification et négociation → partiellement acquis vers 14-15 ans.

- **La lecture-compréhension**

Prise en compte du type de texte, de la ponctuation, du métatexte etc. En France environ 5 à 7% d'illettrés, difficultés de compréhension logique. A l'adolescence apprentissage de nouveaux mots, affinement de l'écrit etc.

Le développement moral et l'idéologie

- **Le raisonnement moral**

Etude de Kohlberg (épreuve du dilemme à partir d'une histoire inventée) : permet d'évaluer le degré de développement moral.
Trois niveaux :

- Morale pré-conventionnelle (6- 10 ans) : stade 1 → peur de la punition, obéissance aux adultes, stade 2 →assimilation action agréable / récompense = bonne action/ action désagréable / punition = mauvaise action.
- Morale conventionnelle (à partir de 10 ans) : stade 3 → bon = valeurs/normes du groupe (famille, pairs, etc.), l'enfant valorise la loyauté/ le maintien de bonnes relations et commence à différencier intention/acte (ex : ne pas faire exprès), stade 4 →élargissement du stade 3 aux institutions, à la société (ex : il faut respecter les lois), apparaît plutôt à l'adolescence.
- Morale post-conventionnelle : principes moraux deviennent autonomes, choix individuels, stade 5 →prise de conscience du contrat social à l'adolescence, stade 6 → rare, principes éthiques universels établis par rapport à des critères personnels, en cas de conflit loi/ conscience, la conscience l'emporte (ex : capacité d'adopter une position minoritaire).

NB : Influence du style éducatif parental (démocratique, autoritaire, permissif ou laisser-faire) dans la formation morale ; jugement moral et comportement ne se superposent pas nécessairement.

- **L'idéologie**

Raisonnement abstrait (politique, éducation, religion), intégration de l'évolution des idées (temps, changements politiques et historiques etc.), référence à des principes généraux plutôt que des opinions particulières.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Adolescence : relations avec les pairs

L'adolescence (4)

Le développement affectif et social

Fluctuation importante de l'estime de soi à l'adolescence (transformations corporelles, changements scolaires), évolution de la définition de soi (caractère, opinions etc.).

- **Relation avec les pairs**

Groupe de pairs = lieu d'échange, d'intégration sociale, avec sa classe d'âge, support d'identifications.
L'appui du groupe de pairs dans la quête identitaire est obtenu plus facilement si l'adolescent a certaines compétences sociales :

- une estime de soi positive (permet d'aller vers les autres)
- un sentiment d'efficacité personnelle (impression d'être acteur de sa vie, de ne pas subir les événements)
- une cognition sociale efficace (une théorie de l'esprit = capacité de se mettre à la place d'autrui, de comprendre les sentiments/intentions/attitudes et donc les comportements de l'autre pour pouvoir y répondre de façon ajustée)
- une capacité à résoudre les problèmes interpersonnels.

Rôle des amitiés adolescentes (affinités, goûts communs, recherche d'un double comme projection idéalisée de soi-même, question des groupes et des bandes etc.), laboratoire d'expérimentation sociale, expériences sexuelles, aide au travail de séparation.
Les pairs deviennent les confidents à la place des parents (2/3 des ados disent sortir volontiers avec des camarades et avoir beaucoup de copains).

Dunphy distingue 2 types de groupes :

- les groupes primaires ou cliques (petits, 3 à 9 individus, proximité géographique de résidence, souvent unisexes, aident à s'éloigner de la famille en sécurité)
- les groupes secondaires ou bandes (plus grands, 10 à 30 individus, mixtes, facilitent l'intégration sociale et les rencontres hétéro/homosexuelles).
- Passage des groupes primaires ou groupes secondaires avec en fin de parcours, désintégration de la bande par la formation de couples plus stables...

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Adolescence : relations familiales et autonomie

L'adolescence (5)

Le développement affectif et social

- **Relations familiales**

❖ *Emancipation de la tutelle parentale :*

La proximité physique devient compliquée d'où une prise de distance éventuellement brutale (comportements provocants, conflits, conduites d'opposition protecteurs par rapport au danger incestueux). En s'opposant, l'adolescent teste la qualité du lien.

❖ *Accès (conflictuel ?) à l'autonomie comportementale et modèles parentaux :*

Minorité d'ados dit être en conflit (moins de 10%), parents = base de sécurité, rôle de la qualité des attachements/ du style éducatif, besoin d'autonomie s'exprime en fonction de la capacité à se séparer des parents (modèle d'autorité → modèle de coopération).

Autonomie comportementale : tout ce que l'adolescent peut faire sans en référer à l'autorité parentale (dans l'organisation de la vie quotidienne, par exemple : coupe de cheveux, habitudes de vie, scolarité, valeurs morales etc.), suscite des conflits (70 à 75% de conflits occasionnels ou fréquents, 5 à 10% de conflits aigus et permanents) mais 60% des ados disent bien s'entendre avec leurs parents, 2/3 disent que leurs parents sont des interlocuteurs privilégiés (sauf pour leur vie intime, affective qu'ils partagent plutôt avec leurs pairs), 15% se plaignent d'un manque d'intérêt et 14% d'un trop d'intérêt de la part de leur parents.

→ Besoin d'un cadre contenant, de limites, ni trop autoritaire (sinon risque d'écrasement de la subjectivité de l'ado) ni trop permissif (sinon risque de confusion incestueuse ou de vécu abandonnique).

- **Ce que dit la théorie de l'attachement**

Remaniement des relations avec les figures d'attachement primaires (parents) en lien avec le processus d'autonomisation et la création de nouveaux liens d'attachement (amicaux, amoureux etc.). Les systèmes sexuel et de caregiving ont une plus grande place, un modèle général des relations d'attachement existe ainsi qu'un affinement du partenariat corrigé quant au but).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Adolescence : identité et difficultés

L'adolescence (6)

Le développement affectif et social

- **La construction de l'identité**

L'image corporelle : craintes maximum vers 13- 14 ans, influence des pairs, médias etc.

Composantes de l'identité :

1) sexuelle (puberté précoce ou non etc.)
2) importance du sentiment de continuité temporelle/ cohésion (non-morcellement)/ singularité
3) identité sociale (cf. travaux de Marcia sur l'identité moratoire à l'adolescence).

- **Les ados en difficulté**

- Difficultés scolaires (résignation apprise, phobies scolaires, risque d'enfermement etc.)
- Dépression (influence d'expériences traumatisantes ou stressantes : divorce, mort d'un membre de la famille, chômage, rejet par les pairs, manque d'estime de soi, échec scolaire, problèmes sentimentaux etc.)
- Tentatives de suicide (rares chez les moins de 12 ans, augmentent après)
- Délinquance (les conduites antisociales existent chez l'enfant mais elles sont plus dangereuses chez les ados, peuvent devenir permanentes → dans les atteintes à la personne type racket etc. 25% filles, victimes d'agressions sexuelles 80% filles)
- Intégration sociale : par la scolarisation essentiellement, responsabilité pénale à 13 ans, mineurs peuvent avoir accès à contraception, travailler (16 ans) mais IVG, mariage, adoption, prélèvement d'organe, changement de nationalité, adhésion à un syndicat avec accord du représentant légal.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Personne âgée : remaniements et aspects affectifs

La personne âgée (1)

Le fait d'être âgé est associé à de nombreux remaniements psychiques (approche de la mort, perte d'autonomie, deuils divers).

Aspects culturels (jeunisme etc.), sociaux (isolement des personnes âgées, mort à l'hôpital plutôt qu'au domicile, vieillissement de la population etc.) à prendre en compte.

Aspects affectifs

- Narcissisme à l'épreuve des transformations corporelles (baisse des capacités physiques) et sociales (moins de contacts sociaux → retraite etc.)
- Angoisse liée à la finitude, deuils multiples (de soi, son image, son travail, ses proches etc.)
- Mécanismes dépressifs, prévalence de certains mécanismes de défense (dénégation, déni, régression)
- D'où l'importance de proposer de nouveaux objets à investir (personnes, activités de loisir etc.).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Personne âgée : attachement

La personne âgée (2)

Aspects affectifs

- **Ce que dit la théorie de l'attachement**

➢ L'attachement à l'âge adulte

2 situations activent particulièrement le système d'attachement de l'adulte :
1) S'occuper d'une figure d'attachement en situation de détresse ou d'incapacité (parents âgés etc.),
2) Devenir parents.
Le phénomène de base de sécurité est modifié de manière cruciale par la réciprocité (chaque partenaire d'une relation d'attachement peut à la fois fournir et recevoir soutien/attention/sécurité), la base de sécurité s'appuie plus sur les échanges verbaux, moins sur le besoin de contact physique, se constituant en zone interne de sécurité.
Notion de **style d'attachement** chez l'adulte (patterns systématisés d'attentes/besoins/émotions/stratégies de régulation émotionnelle/comportements sociaux), et de relation d'attachement (lien affectif durable au sein duquel le partenaire est conçu comme unique, non interchangeable et dont on désire la proximité).

➢ Attachement et sujet âgé

« Les représentations d'attachement sont actives depuis le berceau jusqu'à la tombe » Bowlby.
Etape de la vie réactivant les problématiques typiques de la petite enfance du fait du vieillissement (vulnérabilité, dépendance augmentant la possibilité de situations de détresse et les besoins d'attachement également).
Noyau des figures d'attachement dans l'entourage chez la personne âgée (descendants, conjoint, fratrie, amis etc.) : l'apparition des enfants adultes comme figures d'attachement est caractéristique de cette période.
Notion d'**attachement symbolique** en cas d'absence/disparition de la figure d'attachement (l'évocation des souvenirs suffit à apporter soutien et réconfort), d'attachement aux choses, endroits, animaux domestiques (cadre matériel familier facilitant l'évocation de figures d'attachement disparues).
Chez les personnes démentes, l'attachement est très résistant à la détérioration mentale (répondre à leurs besoins d'attachement permet de renforcer leur sentiment de sécurité).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Personne âgée : cognition et mémoire

La personne âgée (3)

Aspects cognitifs

Altération des fonctions cognitives mais grande variabilité interindividuelle : le vieillissement touche la vitesse de traitement de l'information et les organes sensoriels (baisse de l'acuité). Intelligence fluide baisse mais l'intelligence cristallisée augmente (Cattell, 1960), elle est la dernière à être touchée par les processus détérioratifs pathologiques (démences).

- **Mémoire**

Les résultats d'études sont contradictoires, mais il y a probablement une baisse de la mémoire de travail et des facultés attentionnelles. Reconnaissance fonctionne mieux que rappel. La plainte mnésique n'implique pas forcément une altération pathologique de la mémoire → anxiété, dépression etc. A l'inverse, souvent absence de plainte chez les patients déments type Alzheimer du fait de l'anosognosie.

- **Langage**

Appauvrissement de l'expression spontanée en constructions syntaxiques complexes mais d'autres composantes sont stables (compétences narratives et conversationnelles, compréhension des récits etc.) → importance du niveau socio-culturel et de l'entretien.

La mémoire

- **Définition**

La mémoire est la capacité du cerveau d'enregistrer, de stocker et de récupérer des connaissances acquises

- **Les différentes mémoires**

➢ **Mémoire sensorielle** (Point de départ de la reconnaissance de l'objet, du son etc.)
- L'information reste entre ¼ et 20 s avant que le système cognitif y prête attention ou non
- Capacité limitée d'informations à traiter

➢ **Mémoire à court terme (avec Mémoire de travail)**

MDT :
- Sélectionner, maintenir, comprendre, répéter mentalement ou à haute voix, manipuler l'information
- Traiter l'information (encodage) afin de la mémoriser définitivement (= mise à jour de la MLT)
- Conservation de l'information : 20 à 30 s
- Stockage limité : 7 à 12 informations

MCT :
- Maintien temporaire de l'information (autorépétition mentale)
- Activation des représentations mentales stabilisées dans la MLT sous formes de connaissances
- Récupération de ces connaissances pour être utilisées lors du traitement de l'information

➢ **Mémoire à long terme** (Stockage des connaissances)

La mémoire déclarative ou mémoire explicite = Mémoire qui correspond au rappel conscient et volontaire de connaissances anciennes qui comprend :
- La mémoire épisodique : regroupe des représentations d'événements temporellement datées (événements ou épisodes personnellement vécus)
- La mémoire sémantique : regroupe les connaissances générales nécessaires à la production et la compréhension linguistique (mots, symboles verbaux, significations, référents, etc.)

La mémoire non déclarative ou mémoire implicite = Mémoire qui correspond à la répercussion inconsciente d'expériences anciennes qui comprend :
- La mémoire procédurale : regroupe tous les «savoir-faire» dont l'apprentissage est conscient mais dont la mise en œuvre ensuite est inconsciente (ex : faire du vélo).

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE

Personne âgée : psychopathologie

La personne âgée (4)

Psychopathologie

- **Les démences**

➢ Prévalence augmente avec l'âge (3% des 65- 69 ans, 30% des plus de 90 ans), formes multiples, diagnostic différentiel difficile. Perte des capacités cognitives (variabilité des troubles, de l'évolution, de l'intensité) → il faut au moins présenter un trouble de la mémoire et un trouble d'une autre fonction cognitive (pensée abstraite, langage etc.).

➢ Maladie d'Alzheimer : 50 à 70% des démences, début : troubles mnésiques (oublis de mots, faits récents, mémorisation LT) puis altération des capacités de raisonnement, langage, apraxies (s'habiller, manger etc.), au final : dépendance ++ et impossibilité de communiquer. Troubles anxieux associés, difficultés pour les proches (ne pas être reconnu, troubles du comportement du malade, culpabilisation par rapport à hospitalisation/institutionnalisation, épuisement etc.) et les équipes soignantes.

- **La dépression et le risque suicidaire**

➢ Deuils, isolement social etc. → 10 à 20 % de dépression chez les plus de 65 ans (tristesse, ralentissement psychomoteur plus difficiles à évaluer chez le sujet âgé, idem pour insomnie, troubles cognitifs peuvent évoquer une démence), polymorphisme des manifestations dépressives.

➢ Geste suicidaire à plus haut risque létal chez la personne âgée (gare aux annonces de maladies chroniques douloureuses ou mortelles) → besoin d'une prise en charge polyvalente.

Conclusion : à l'hôpital, nécessité de favoriser l'autonomie, l'activité (physique, intellectuelle, intégration sociale), risque chez les soignants de mise à distance (angoisse de mort), infantilisation favorisant régression et dépendance → majoration des symptômes.

université PARIS-SACLAY | FACULTÉ DE MÉDECINE